جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : نصره ابراهيم ابراهيم المزين
المحافظة : الغربيه **الحي / المدينة :** قطور **العنوان :** --------
رقم البطاقة : 25401081601908 **رقم التليفون :** 01068915109 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 08-01-1954 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: نصره ابراهيم ابراهيم المزين
National ID: 25401081601908

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name	: الأستاذه / نصره ابراهيم ابراهيم المزين	Request No.	: 13001488
Patient No.	: 25401081601908	Request Date	: 08/06/2023
Path No.	: 1814/23	Verification Date	: 25/06/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 69 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

- Her2: Negative (score 0).
- Ki67: Positive in 5% of tumor cells.

Signature

Prof. Dr. Gamal Abdelaty
Dr. Heba Hassan

Prof. Dr. Lobna Omar
Dr. Heba Hassan

Verified by :
DR.Menna Nabil

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (237) - كورنيش النيل - معهد الكبد القومي - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 237- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / نصره ابراهيم ابراهيم المزين	Request No.	: 13001488
Patient No.	: 25401081601908	Request Date	: 08/06/2023
Path No.	: 1814/23	Verification Date	: 25/06/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 69 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast swelling
Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 07/06/2023, 03:15 pm.

Gross Examination:
- Multiple brownish fatty tissue cores up to 0.6 cm, totally submitted.
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic Examination:
* Histological type: Invasive duct carcinoma.
* Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
* DCIS: No.
* Angioinvasion: No.
* IPT (Positive control showed appropriate reactivity):
- Calponin: Negative.
- P63: Negative.
- ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (Allred score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (Allred score 8/8)
- Her2: No membrane reaction in tumor cells (score 0)
- Ki67: 5% nuclear reaction of tumor cells.

Diagnosis:
Left breast mass, Tru cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II.
IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).

Verified by :
DR.Menna Nabil

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (257) - المرايش النيل - معهد ناصر - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 257- Nile Corniche - Misr El Qadema- Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : نصره ابراهيم ابراهيم المزين Sex: Female
3- Medical number: 83153000
Old Med : 2960-2023
2-ID number: 25401081601908
Patient Age : 70 Y

Family history	-VE	Phone	01068915109	BMI		REASON OF MDT	POST OPERATIVE
marital status	MARRID	NRS Score		GROUP	A	Date of MDT	2023-10-03
Co morbidity	DM,HTN	Menopausal status	POSTMENOPAUSAL				

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :
CT CAP : cirrhotic liver WITH MODRERATE PORTAL HTN
RT LOWER LUNG LOBE NODULE

BX:	ER:	PR:	Her 2 Neu :	SISH :	Ki67 :
IDC	8/8	8/8	0		5

T	N	M
2	0	0

Sonomammography
LT UOQ mass 5.5*10cm

PATIENT HISTORY
LT MRM:
free deep margins
free nipple , areola
free LNs 0/13
PT2 PN0

MDT OUTCOME & PLAN

FOR ADJ AI
ZOMETA

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	د/ شريف حسانين د/ احمد شاهين	RADIOLOGY	د/ هبه فرج
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

مستشفيات جامعة طنطا
قسم الأشعة التشخيصية
المستشفى التعليمى العالمى

Tanta Universal Teaching Hospital
مستشفى جامعة طنطا التعليمى العالمى

Patient Name:Nasra Ibrahim

Date:20/7/2023

Examination: Contrast CT of the Chest, abdomen and pelvis with Contrast

Known case of left breast cancer:

CT chest findings:

- Lateral segment of right lower lung lobe sub-pleural nodule about 7 mm.
- Enlarged mediastinal lymph nodes namely pre-vascular, para-tracheal and sub-caval groups, the largest seen at right para-tracheal group measures about 17x8 mm.
- Left breast irregular speculated soft tissue lesion measured about 3.3x7.5 cm.
- Pulmonary structure is normal and shows normal vascular markings.
- The heart is orthotopic with normal configuration ,the cardiac chambers are of normal size.
- Major intrathoracic vessels and imaged portions of the supra-aortic vessels are unremarkable.
- The thoracic skeleton and thoracic soft tissues show no abnormalities.

CT abdomen and pelvis findings:

- Average sized cirrhotic features, left and caudate lobes with prominent fissures and irregular outlines with no focal lesions.
- Portal vein is seen dilated about 18 mm with patent lumen.
- Non visualized spleen (history of surgical removing)
- Gall bladder is of average wall thickness with no detectable stones.
- The pancreas is normal in size, position, and internal structure with smooth, lobulated outer contours. The pancreatic duct is unobstructed.
- Both kidneys show normal size and position. The renal parenchyma shows normal width and structure. The renal pelvis and calices show a normal configuration. The urinary drainage tract is unobstructed.
- The adrenal glands are unremarkable.
- Major blood vessels appear normal, and there is no evidence of lymphadenopathy.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

- Major blood vessels appear normal, and there is no evidence of lymphadenopathy.
- Imaged portions of the lung and soft tissues are normal.
- Imaged bowel structures, especially the cecum and rectum, show no abnormalities with no evidence of wall thickening or mass lesions. The peri rectal fat and ischio-rectal fossa are unremarkable.
- The adequately distended urinary bladder has smooth outer contour and normal wall thickness.
- Non visualized uterus (history of surgical removal).
- N.B: Spondylodegenerative changes of scanned spine.

Opinion:

Known case of left breast cancer:

- Average sized cirrhotic liver with no sizable focal lesion associated with moderate portal hypertension.
- Right lower lung lobe sub-pleural nodule and mediastinal lymph nodes as described above.

Dr. Basma Eldeeb(Lect.)
Dr. Rania Abdelrahman (Ass. Lect.)

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]